

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA
RECHERCHE SCIENTIFIQUE

Université Saleh Bounider
Faculté de médecine
3^{ème} année médecine

DISTOMES ET DISTOMATOSES

Dr. LETLOUT. M
Maître assistante en parasitologie- mycologie

Année universitaire : 2024/2025

1. Introduction

Les distomatoses sont des **zoonoses** qui affectent principalement les mammifères et accidentellement l'homme. Elles sont causées par des trématodes appelés **douves** ou **distomes** qui vivent au contact des épithéliums.

L'infestation se fait toujours par **voie orale** avec des aliments variables selon les pays et les espèces.

Ces parasites peuvent affecter différents organes, ce qui permet de les classifier en trois catégories principales, en fonction de l'organe atteint :

- **Distomatoses Hépatobiliaires** : Affectent le foie et les voies biliaires.
 - *Fasciola hepatica* (2-3cm)
 - *Fasciola gigantica* (3-7cm)
 - *Dicrocoelium dendriticum* (1cm)
- **Distomatoses Intestinales** : Affectent le système digestif.
 - *Fasciolopsis buski* (3-7cm)
 - *Heterophyes heterophyes* (2mm)
- **Distomatoses Pulmonaires** : Affectent les poumons et les voies respiratoires.
 - *Paragonimus westermani* (1cm)

En Algérie, seule la distomatose hépatobiliaire ou fasciolose à *Fasciola hepatica* est pathogène pour l'homme. Cette infection parasitaire est relativement rare dans le pays. La transmission se fait par la consommation de végétaux semi-aquatiques, notamment le cresson sauvage récolté dans des zones contaminées.

2. Epidémiologie

2.1. Taxonomie

- **Règne** : Animalia -
- **Phylum** : Plathelminthes (Vers plats non segmentés à symétrie bilatérale).
- **Classe** : Trématodes (Vers foliacés parasites avec tube digestif incomplet)
- **Sous-classe** : Digènes (Possèdent deux ventouses)
 - Douves (Hermaphrodites)

2.2. Morphologie des Douves

➤ **Douve Adulte** : des vers plats, non segmentés, d'aspects foliacés et hermaphrodites
Ils possèdent 2 ventouses :

- **Ventouse antérieure ou orale (VO)** : Contient l'orifice buccal (OB), le pharynx musculueux et un œsophage court.
- **Ventouse ventrale ou acétabulum (VV)**.
- **Œufs** : Ovoïdes et symétriques, operculés. Embryonnés ou pas à la ponte (selon les espèces). Eclosion en milieu aquatique et libération d'un embryon cilié : miracidium.

2.3. Cycle Évolutif Général des Douves

Le cycle évolutif des douves est **hétéroxène** (nécessite plusieurs hôtes), complexe, avec des exigences biologiques strictes.

- **Hôte Définitif (HD)** : Mammifères (bovins, ovins, homme, porc, chats, chiens). L'HD ingère le 2ème hôte intermédiaire (HI) contenant les métacercaires. Les douves adultes s'installent dans l'organe cible (voies biliaires, muqueuse intestinale, poumons) et émettent des œufs dans les selles.
- **1er Hôte Intermédiaire (HI1)** : Mollusque d'eau douce (ex: *Lymnaea truncatula*, *Bithynia*, *Planorbis*, *Pirenella*). Le miracidium libéré de l'œuf pénètre le mollusque, où il se transforme en sporocyste, puis en rédies, puis en cercaires.
- **2ème Hôte Intermédiaire (HI2)** : Végétal ou animal. Les larves cercaires nagent et s'enkystent sur le 2ème HI pour former les métacercaires.
 - **Végétaux semi-aquatiques** (mâche, cresson, pissenlit) : Vecteurs de la fasciolose à *Fasciola hepatica*.
 - **Poissons d'eau douce ou de mer** (mulet) : Vecteurs de *Clonorchis sinensis*, *Opisthorchis felinus*, *Heterophyes heterophyes*.
 - **Crabes, crevettes d'eau douce** : Hôtes intermédiaires pour les douves du poumon comme *Paragonimus* sp.
 - **Fourmis** : Vecteurs de la petite douve du foie *Dicrocoelium dendriticum*.

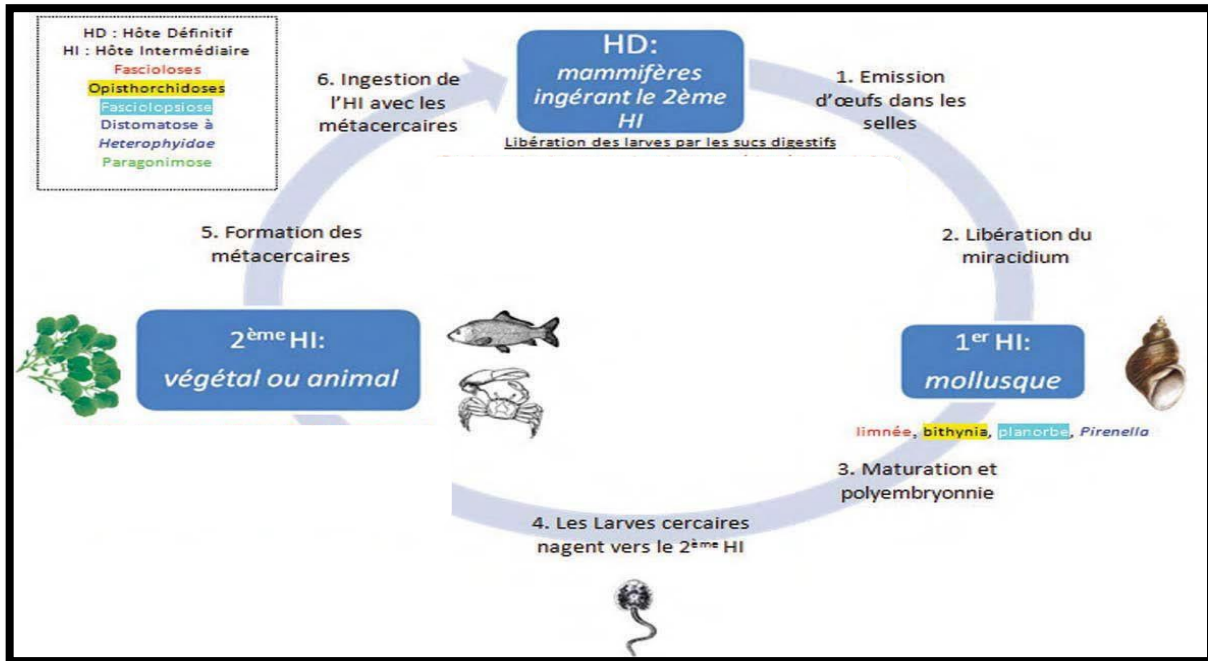


Figure: Cycle évolutif des douves

Fasciolose à *Fasciola hepatica*

1. Introduction

La fasciolose est une distomatose due à *Fasciola hepatica*, localisée à l'état adulte dans les voies hépato-biliaires de nombreux herbivores et accidentellement l'homme. Il s'agit d'une zoonose commune à l'homme et à certaines espèces de mammifères domestiques ou sauvages.

L'infestation de l'homme est liée à la consommation de végétaux semi-aquatiques sauvages crus. Elle peut être responsable de petites épidémies familiales (qui ont partagé le même repas).

2. Épidémiologie

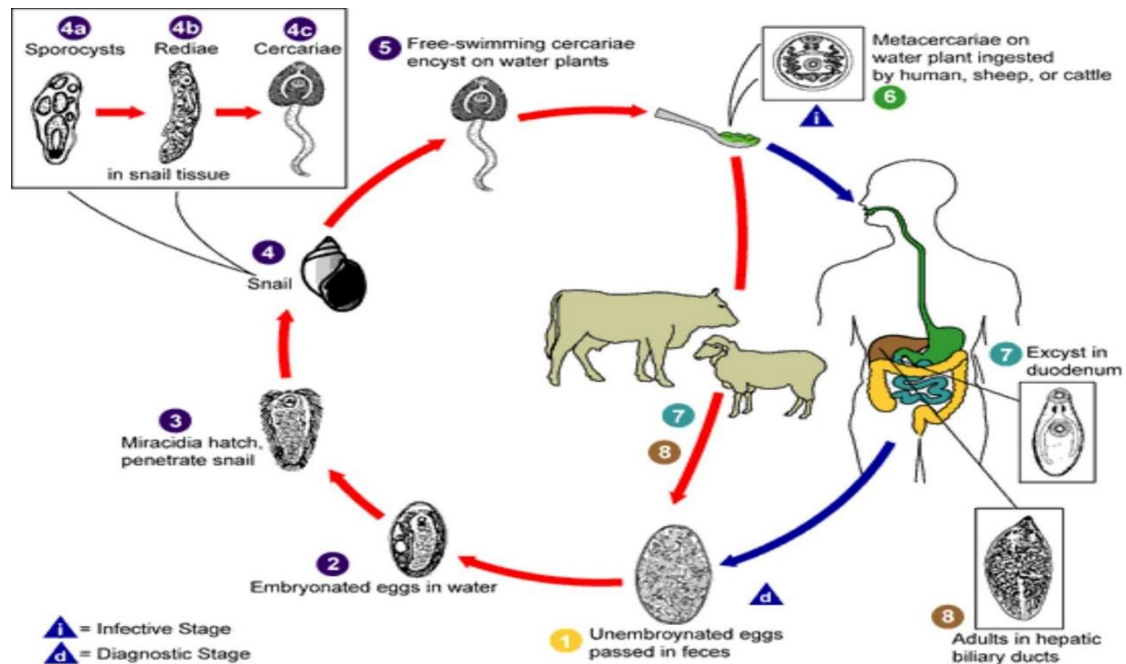
- **Morphologie :**

- **Adulte** : Mesure 2-3 cm de longueur. Corps foliacé aplati, blanc au centre et foncé à la périphérie, avec un cône céphalique caractéristique.

➤ **Œuf** : 140 µm, brun, operculé, coque lisse. Émis dans les selles. Non embryonné à la ponte.

- **Cycle évolutif :**

- **HD** : Bovins, ovins... / Homme.
- **HI1** : Mollusque d'eau douce (*Lymnaea truncatula*).
- **HI2** : Plante aquatique : Cresson+++, pissenlit... (support seulement).
- Le cycle complet (de la contamination à la ponte ovulaire) dure 2 à 3 mois.



- **Mode de contamination** : Consommation de plantes aquatiques crues (cressons, mâche, pissenlit) contaminées par des métacercaires enkystées.
- Elle est à l'origine de petites épidémies familiales ou collectives.
- Elle a caractère saisonnier (Fin d'été/Automne : Période à haut risque de contamination humaine)
- Étés pluvieux (favorables à la limnée) augmentent les risques de contamination.
- **Réservoir** : Herbivores (bovins, ovins)
- Répartition géographique : Cosmopolite.
- Dans le monde, les pays à forte prévalence : Egypte, Iran, Argentine, pays andins. En Algérie, les foyers atteints sont : Jijel+++, El Kala.

3. Clinique

La fasciolose évolue en plusieurs phases cliniques :

1. **Phase d'incubation** : Asymptomatique, dure environ 15 jours.
2. **Phase d'invasion** : Hépatite toxi-infectieuse +/- sévère, environ 15 jours après le repas infestant. (Troubles digestifs vagues, manifestations allergiques, hépatomégalie douloureuse et fébrile)
3. **Phase d'état** : Complications mécaniques et inflammatoires, environ 3 mois après l'infestation. (Angiocholite, Cholécystite, Crises pseudo lithiasiques, Pancréatite...)

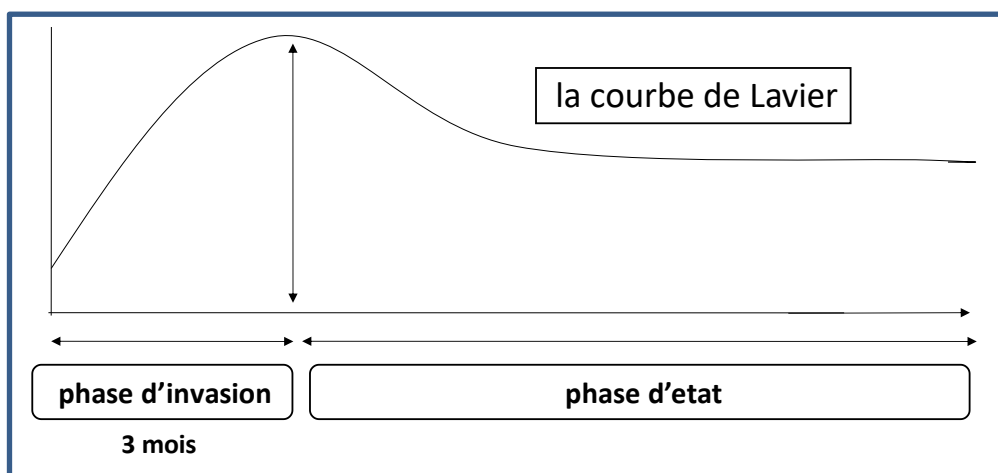
4. Diagnostic

Le diagnostic dépend de la phase évolutive de la maladie

4.1.Éléments d'orientation

- **Éléments anamnestiques** : Consommation récente de végétaux sauvages (cresson+++), cas similaires dans l'entourage (épidémies familiales), caractère saisonnier des symptômes, séjour en zone d'endémie.
- **Éléments biologiques** :
 - **Hyperéosinophilie sanguine importante**: évoluant selon **la courbe de Lavier**
Augmentation vers J15, Pic maximal entre 2ème et 3ème mois (élément important du diagnostic),

Diminution progressive après plusieurs mois, vers une valeur résiduelle toutefois supérieure à la normale.



4.2. Diagnostic de certitude

- **Examen Parasitologique des Selles (EPS)** : Recherche des œufs dans les selles.

Recherche des œufs dans les selles à l'examen direct et après concentration (frottis fécal épais éclaircit par la glycérine = Kato).

EPS positif 3 mois après l'infestation.

NB : La ponte est irrégulière et cet examen doit être répété tous les 3 jrs

Les pontes cessent après plusieurs années d'évolution

- EPS négatif n'élimine pas le diagnostic :
 - ✓ Avant 3 mois les douves sont encore immatures
 - ✓ Après 3mois la ponte est souvent faible
 - ✓ Les formes chroniques : absence de ponte

4.3. Diagnostic sérologique

Le diagnostic sérologique constitue une alternative précieuse à l'examen parasitologique des selles, particulièrement pendant la phase d'invasion précoce. Il présente plusieurs avantages :

- Positivité très précoce, avant même l'apparition des symptômes.
- Sensibilité élevée, permettant de détecter les infections à faible charge parasitaire.
- Utilité dans les formes chroniques où la ponte peut être absente.
- **Techniques Sérologiques** : Électrosynérèse. ELISA.

5. Traitement

TRICLABENDAZOLE antihelminthique de la famille des Benzimidazolés. Parasiticide sur les formes Immatures et adultes de *F. hepatica*.

10 mg/kg prise unique au cours d'un repas.

6. Prophylaxie

Prophylaxie Individuelle

- Éviter de consommer les crudités sauvages (cresson, mâche, pissenlit).
- La cuisson à T > 60°C tue les métacercaires.
- **NB** : Le lavage des feuilles est insuffisant pour éliminer les métacercaires.

Prophylaxie Collective

- Dépistage et contrôle vétérinaire.
- Epandage des mollucides inoffensifs pour les animaux et l'homme !!
- Education sanitaire (dangers de la consommation de végétaux sauvages).
- Surveillance des cultures de cresson.